



Menenjit

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen ve onları koruyan meninks adı verilen zarların iltihaplanmasıdır. Enfeksiyona bağlı olarak gelişebileceği gibi bazı enfeksiyon dışı nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler menenjite neden olabilir. Özellikle bakteriyel menenjit, hızlı ilerleyebilen ve yaşamı tehdit edebilen ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle menenjit şüphesinde erken tıbbi değerlendirme önemlidir.

Menenjit dünyanın her bölgesinde görülebilir ancak görülme sıklığı bölgelere göre önemli farklılıklar gösterir. Bakteriyel menenjitin en yüksek görüldüğü bölgelerden biri, Sahra Altı Afrika'da Senegal'den Etiyopya'ya uzanan "menenjit kuşağı" olarak adlandırılan bölgedir. Kaynaklara göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon bakteriyel menenjit vakası ve 300.000 ölüm bildirilmiştir. Viral menenjit ise bakteriyel menenjitten daha sık görülür ve çoğunlukla daha hafif seyretmektedir.

Menenjitin belirtileri hastalığın nedenine ve ilerleme hızına göre değişebilir. En sık görülen belirtiler ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği, bulantı-kusma, ışığa duyarlılık ve bilinç veya zihinsel durumda değişiklikler. Bazı hastalarda nöbet, güçsüzlük ve deri döküntüsü de görülebilir.

Bakteriyel menenjit bazı kişilerde birkaç gün içinde giderek kötüleşirken, bazı vakalarda belirtiler çok daha hızlı ortaya çıkabilir. Özellikle meningokok enfeksiyonunda hastalık birkaç saat içinde ağırlaşarak sepsis ve dolaşım bozukluğuna ilerleyebilir. Bebeklerde ise belirtiler farklı olabilir; beslenme güçlüğü, aşırı uyku hali, huzursuzluk, sürekli ağlama ve bingüldakta şişme görülebilir.

Menenjite neden olan etkenler arasında bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler bulunur. Bakteriyel menenjitin önemli nedenleri Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae ve B grubu streptokoklardır. Viral menenjitte ise özellikle polio dışı enterovirüsler öne çıkmaktadır.

Risk; küçük yaş, bağışıklık sisteminin zayıflaması, yetersiz aşılama ve kalabalık ortamlarda yaşama gibi durumlarda artabilir. Ayrıca kafa travması, beyin ameliyatı, beyin omurilik sıvısı sızıntısı, dalak bulunmaması veya hasarlı olması ve bazı kronik hastalıklar da riskle ilişkilidir. Özellikle beyin omurilik sıvısı sızıntısı olanlar, dalağı alınmış veya hasarlı olanlar ile kafa travması geçirenlerde risk belirgin şekilde yükselir.

Menenjite neden olan etkenler kan dolaşımı yoluyla, sinir yollarını kullanarak veya yakınındaki enfekte bölgelerden doğrudan merkezi sinir sistemine ulaşabilir. Bakteriler beyin-omurilik sıvısının bulunduğu alanlara ulaştığında burada çoğalarak güçlü bir iltihabi yanıt başlatır. Bu süreç kan-beyin bariyerinin bozulmasına, beyin ödeme ve iskemiye yol açabilir. Oluşan iltihap ve yapısal değişiklikler sinir hücrelerinde

hasara neden olarak hastalığın ciddi sonuçlar doğurmasına katkıda bulunur.

Menenjit tanısında öykü ve fizik muayenenin yanı sıra en önemli incelemelerden biri lomber ponksiyonla alınan beyin omurilik sıvısının (BOS) değerlendirilmesidir. BOS'ta hücre sayımı, glikoz, protein, Gram boyama ve kültür incelemeleri yapılabilir. Etkenin belirlenmesinde PCR ve diğer hızlı moleküler testlerden de yararlanılabilir. Kan testleri ve kan kültürleri de tanıyı destekler.

Bakteriyel menenjit düşünüüyorsa tedavi, tanısal işlemler nedeniyle geciktirilmemelidir. Bazı hastalarda lomber ponksiyon öncesinde bilgisayarlı tomografi gerekebilir.

Menenjit acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Bakteriyel menenjit şüphesinde antibiyotik tedavisi mümkün olan en kısa sürede başlanır. Bazı durumlarda antibiyotiklerle birlikte deksametazon gibi kortikosteroidler kullanılabilir.

Viral menenjitte ise çoğu hafif vakada özel bir tedavi gerekmeden dinlenme, yeterli sıvı alımı ve ateş veya ağrı kontrolü ile iyileşme görülebilir. Herpes virüsü veya grip kaynaklı vakalarda antiviral tedavi kullanılabilir. Mantar menenjiti ise genellikle uzun süreli ve yüksek doz intravenöz antifungal ilaçlarla tedavi edilir. Tedavi, menenjitin nedenine göre belirlenir.

Menenjit sonrası sonuçlar hastalığın etkenine, hastanın yaşına ve bağışıklık durumuna



göre değişir. Özellikle bakteriyel menenjit ölümle sonuçlanabilir ve iyileşen kişilerde işitme kaybı, nöbetler, öğrenme ve bilişsel sorunlar, görme veya hareket bozuklukları ve hafıza problemleri gibi kalıcı etkiler bırakabilir. Beyin ödemi, hidrosefali ve çeşitli nörolojik bozukluklar da gelişebilir. Viral menenjit genel olarak daha iyi seyretse de bazı vakalarda ciddi nörolojik sonuçlar ortaya çıkabilir.

Menenjitte karşı korunmada aşılama en önemli yöntemlerden biridir. Hib, pnömokok ve meningokoklara karşı aşılar bulunmaktadır. Özellikle Afrika menenjit kuşağında A, C, W, Y ve X serogruplarına karşı koruma sağlayan beş bileşenli meningokok aşısının kullanıma sunulması, salgınlara azaltılması açısından önemli bir gelişmedir.

Sonuç olarak menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve özellikle bakteriyel türü ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği ve bilinç değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tanıda özellikle beyin omurilik sıvısının incelenmesi önem taşırken, tedavi hastalığa neden olan etkene göre antibiyotik, antiviral veya antifungal ilaçlarla yapılır. Erken tanı ve uygun tedavi, ölüm ve kalıcı nörolojik hasar riskini azaltmada büyük önem taşır. Aşılama ise menenjitten korunmanın en etkili yollarından biridir.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2025, April 1). Meningitis. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis>
- 2) Tristram, D., & Kondamudi, N. P. (2026, February 15). Meningitis. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459360/>
- 3) Yücelen Hospital Medical Publication Board. (n.d.). Meningitis. Yücelen Hospital. <https://www.yucelenhastanesi.com/en/i-cerikler/menenjit>
- 4) Maude, R. R. (2023, December 18). Meningitis. MedPark Hospital. <https://www.medparkhospital.com/ja-JP/disease-and-treatment/meningitis>

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2026

Sorumlu Yazar: Ali Bocakkıtaç/ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi